

CAPÍTULO 14.1

Esquema General de Reumatología

PERFIL EUNACOM 1.05.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La reumatología es una de las áreas de la medicina interna que genera mayor confusión debido a la superposición de síntomas entre las distintas patologías autoinmunes. Para abordar el estudio del **EUNACOM**, es fundamental contar con un esquema mental claro que permita clasificar estas enfermedades según su fisiopatología, marcadores inmunológicos y presentación clínica.

1. Enfermedades del Tejido Conectivo (ETC)

Este grupo de patologías se caracteriza por una desregulación del sistema inmune que ataca componentes del colágeno y otras proteínas del tejido conectivo.

- El exponente más clásico es el **Lupus Eritematoso Sistémico (LES)**, pero el grupo es amplio e incluye:
- **Esclerodermia Sistémica:** Caracterizada por fibrosis cutánea y visceral.
- **Polimiositis y Dermatomiositis:** Miopatías inflamatorias que afectan el músculo proximal (y la piel en el caso de la dermatomiositis).
- **Síndrome de Sjögren:** Afectación de glándulas exocrinas (ojo y boca seca).
- **Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC):** Un síndrome de superposición con características de LES, esclerosis sistémica y polimiositis.

NOTA CLÍNICA

El factor común: Todas estas enfermedades tienden a presentar positividad para los **Anticuerpos Antinucleares (ANA)**. Los ANA son el marcador de tamizaje (screening) inicial debido a su alta sensibilidad, aunque su especificidad varía según el patrón y los anticuerpos específicos (como el anti-DNA o anti-Sm).

2. Espondiloartropatías Seronegativas

A diferencia de las ETC, este grupo afecta principalmente el **esqueleto axial** (columna y articulaciones sacroilíacas) y las entesis (lugar donde el tendón se inserta en el hueso).

- Las patologías principales son:
- **Espondilitis Anquilosante (EAA):** El prototipo, con compromiso sacroilíaco bilateral.
- **Artritis Psoriática:** Asociada a lesiones cutáneas de psoriasis.
- **Artritis Reactiva:** Aparece tras una infección (digestiva o genitourinaria).
- **Artritis asociada a Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII):** Relacionada con **Colitis Ulcerosa** o **Enfermedad de Crohn**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Se denominan "**Seronegativas**" porque clásicamente presentan **Factor Reumatoide (FR) negativo** y ausencia de ANA. Su marcador genético característico es el **HLA-B27**.

3. Vasculitis Primarias

Las vasculitis son procesos inflamatorios de las paredes de los vasos sanguíneos que provocan isquemia y daño orgánico. Se clasifican tradicionalmente según el tamaño del vaso afectado:

TABLA 14.1.1: TAMAÑO DEL VASO VS PATOLOGÍAS PRINCIPALES

TAMAÑO DEL VASO	PATOLOGÍAS PRINCIPALES	MARCADORES / CARACTERÍSTICAS
Vaso Grande	Arteritis de Takayasu, Arteritis de Células Gigantes (Temporal).	Afectan aorta y sus ramas principales.
Vaso Mediano	Enfermedad de Kawasaki, Poliarteritis Nodosa (PAN).	Pueden afectar arterias coronarias o renales.
Vaso Pequeño	Púrpura de Henoch-Schönlein, Granulomatosis de Wegener (GPA), Churg-Strauss (EGPA), Poliangeitis Microscópica (PAM).	Las últimas tres son típicamente ANCA positivos .

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Aunque la clasificación por tamaño es útil, en la práctica clínica existe **solapamiento**. Por ejemplo, la Poliarteritis Nodosa puede afectar vasos pequeños en ciertos contextos, y no siempre se respeta estrictamente el calibre vascular en la presentación clínica.

4. Otras Enfermedades Autoinmunes e Inflamatorias

Existen patologías que no encajan perfectamente en los grupos anteriores pero son de alta relevancia clínica:

- **Artritis Reumatoide (AR):** Es la enfermedad inflamatoria poliarticular más frecuente. Aunque algunos la incluyen en las ETC, suele estudiarse aparte. Se caracteriza por ser simétrica, erosiva y afectar articulaciones pequeñas (manos/pies), generalmente con **ANA negativo** pero **Factor Reumatoide y Anti-CCP positivos**.
- **Enfermedad de Still del Adulto:** La versión adulta de la Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) sistémica. Se presenta con fiebre alta, rash evanescente y artritis.
- **Enfermedad de Behçet:** Una vasculitis de vasos de calibre variable que destaca por aftas orales y genitales recurrentes, además de uveítis.

5. Patologías Reumatológicas No Autoinmunes

No todo dolor articular es autoinmune. Es vital diferenciar los cuadros inflamatorios de los mecánicos o metabólicos:

- **Artrosis (Osteoartritis):** Patología degenerativa del cartílago articular. Es la causa más común de consulta reumatológica.
- **Fibromialgia:** Síndrome de dolor crónico generalizado con componente neuromuscular y de sensibilización central, sin inflamación articular objetiva.
- **Artritis por Cristales:**
 - **Gota:** Depósito de cristales de urato monosódico (asociado a hiperuricemia).
 - **Condrocálcinosis (Pseudogota):** Depósito de cristales de pirofosfato de calcio.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, ante un paciente con una monoartritis aguda (especialmente en la primera metatarsofalángica o rodilla), siempre se debe sospechar primero una **Artritis por Cristales** o una **Artritis Séptica**.

Resumen de Marcadores Inmunológicos

Para orientar el diagnóstico diferencial, recuerda esta asociación rápida:

- **ANA (+):** Sugiere Enfermedad del Tejido Conectivo (**Lupus Eritematoso Sistémico**, Esclerodermia, etc.).
- **ANCA (+):** Sugiere Vasculitis de vaso pequeño (Wegener, PAM, Churg-Strauss).

- **HLA-B27 (+):** Sugiere Espondiloartropatías (Espondilitis Anquilosante).
- **Factor Reumatoide / Anti-CCP (+):** Sugiere **Artritis Reumatoide**.
- **Seronegativas (Todo -):** Espondiloartropatías, Artrosis, Fibromialgia.

Este esquema general sirve como mapa para navegar por los temas específicos de la reumatología, permitiendo organizar la información clínica y de laboratorio de manera coherente para el examen.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Cuál de las siguientes características es común a todas las enfermedades del tejido conectivo?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Esquema General de Reumatología. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Las enfermedades del tejido conectivo (lupus, esclerodermia, polimiositis, dermatomiositis, Sjögren, EMTC) son ANA positivas
- Las pelvispondiloartropatías (espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, artritis reactiva, artritis asociada a EI) son seronegativas
- Las vasculitis se clasifican por tamaño de vaso: grande (Takayasu, células gigantes), mediano (Kawasaki, PAN), pequeño (Schönlein-Henoch, Wegener, Churg-Strauss, PAM)
- Las tres vasculitis ANCA positivas son granulomatosis de Wegener, Churg-Strauss y poliangeítis microscópica
- La artritis reumatoide no suele ser ANA positiva y se clasifica aparte de las ETC
- La enfermedad de Behçet es una vasculitis con clínica diferente que se clasifica aparte
- Enfermedades reumatológicas no autoinmunes incluyen artrosis (degenerativa), fibromialgia (neuromuscular) y artritis por cristales (metabólica)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ESQUEMA GENERAL DE REUMATOLOGÍA)

PREGUNTA 1

¿Cuál de las siguientes características es común a todas las enfermedades del tejido conectivo?

- A)** Son ANCA positivas
- B)** Son ANA positivas
- C)** Son seronegativas
- D)** Se asocian al HLA-B27
- E)** Presentan factor reumatoide positivo

PREGUNTA 2

¿Cuál de las siguientes enfermedades NO pertenece al grupo de las pelvispondiloartropatías seronegativas?

- A)** Espondilitis anquilosante
- B)** Artritis psoriásica
- C)** Artritis reactiva
- D)** Dermatomiositis
- E)** Artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal

PREGUNTA 3

¿Cuáles son las tres vasculitis primarias que se caracterizan por ser ANCA positivas?

- A)** Arteritis de Takayasu, arteritis de células gigantes y enfermedad de Kawasaki
- B)** Poliarteritis nodosa, púrpura de Schönlein-Henoch y enfermedad de Kawasaki
- C)** Granulomatosis de Wegener, vasculitis de Churg-Strauss y poliangeítis microscópica
- D)** Arteritis de células gigantes, poliarteritis nodosa y granulomatosis de Wegener
- E)** Enfermedad de Kawasaki, púrpura de Schönlein-Henoch y arteritis de Takayasu

RESUMEN: ESQUEMA GENERAL DE REUMATOLOGÍA

Esta clase presenta un esquema general de las enfermedades reumatológicas más importantes, organizándolas en grandes categorías para facilitar su comprensión y diferenciación. Se revisan las enfermedades del tejido conectivo (ETC), las pelvispondiloartropatías, las vasculitis y otras enfermedades reumatológicas relevantes. Las enfermedades del tejido conectivo incluyen lupus, esclerodermia sistémica, polimiositis, dermatomiositis, síndrome de Sjögren y enfermedad mixta del tejido conectivo, todas caracterizadas por ser ANA positivas. Las pelvispondiloartropatías (espondilitis anquilosante, artritis asociada a EII, artritis psoriásica, artritis reactiva) son seronegativas, sin anticuerpos positivos, aunque pueden presentar marcadores genéticos HLA. Las vasculitis primarias se clasifican por tamaño de vaso: grande (arteritis de Takayasu, arteritis de células gigantes), mediano (enfermedad de Kawasaki, poliarteritis nodosa) y pequeño (púrpura de Schönlein-Henoch, granulomatosis de Wegener, vasculitis de Churg-Strauss, poliangeítis microscópica). Las tres últimas son ANCA positivas. Finalmente, se mencionan enfermedades reumatológicas no autoinmunes como artrosis (degenerativa), fibromialgia (neuromuscular) y artritis por cristales (metabólica).